

Le HoLEP est une chirurgie laser pour l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) qui retire le tissu obstructif interne à l'aide d'un endoscope — **sans incision externe**. Son grand avantage est qu'il s'applique à **toute taille de prostate**, y compris les très volumineuses qui nécessitaient autrefois une chirurgie ouverte, avec peu de saignements et des résultats durables.

À propos de cette intervention

Par un endoscope introduit dans l'urètre, un **laser holmium** décolle l'intégralité du tissu prostatique interne (la partie qui cause le blocage) de sa capsule externe — comme retirer la chair d'un fruit de sa peau. Le tissu libéré est poussé dans la vessie, puis fragmenté et extrait (**morcellation**). En retirant toute la portion obstructive, les résultats sont **durables** et un nouveau traitement est rarement nécessaire.

Pourquoi choisir le HoLEP

- **Efficace pour toute taille** de prostate, y compris les très volumineuses
- **Faible saignement** — souvent possible même sous anticoagulants
- Durée de sondage courte et résultats durables

Il s'agit d'une technique spécialisée — les meilleurs résultats sont obtenus avec un chirurgien expérimenté.

COMPRENDRE LES TERMES

HoLEP

Énucléation de la prostate au laser holmium.

HBP

Hypertrophie bénigne (non cancéreuse) de la prostate.

Énucléation

Retrait complet du tissu prostatique interne de sa capsule.

Laser holmium

Laser utilisé pour séparer et cautériser le tissu avec peu de saignement.

Morcellation

Fragmentation du tissu libéré pour pouvoir l'extraire.

Éjaculation rétrograde

Orgasme à sec — effet secondaire courant et sans danger.

QU'EST-CE QUI CHANGE APRÈS ? La plupart des hommes obtiennent un jet urinaire fort et durable. Comme pour les autres chirurgies de la prostate, l'**éjaculation rétrograde** (orgasme à sec) est fréquente. Certains hommes ont une urgenterie temporaire ou de légères fuites d'effort dans les premières semaines, qui se résolvent presque toujours ; les effets sérieux sur les érections ou une incontinence urinaire persistante sont rares.

Comment vous préparer

- Intervention sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — respectez les consignes de jeûne et de médicaments.
- Un **examen d'urine** pour exclure une infection avant l'opération.
- Prévoyez un accompagnant ; une courte période de sondage est à prévoir.

Déroulement & Après

- 1 Vous êtes endormi(e) ou insensibilisé(e) ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Le laser énuclée le tissu prostatique interne, qui est ensuite morcellé et retiré.
- 3 Une sonde est placée, généralement retirée en **environ un jour** ; beaucoup de patients rentrent le jour même ou après une nuit.

Attendez-vous à des **urines rosées** et à quelques brûlures ou urgenteries pendant quelques semaines ; faites les exercices du plancher pelvien si conseillé, et évitez les efforts et le port de charges lourdes.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Impossibilité d'**uriner** après le retrait de la sonde
- **Saignements abondants ou caillots** bloquant le flux
- Fièvre ou frissons
- Des fuites qui ne s'améliorent pas dans les premières semaines

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le HoLEP utilise un laser pour retirer tout le tissu prostatique obstructif par endoscope — il est efficace pour **toute taille** de prostate, avec peu de saignements et des résultats durables.
2. Attendez-vous à un jet fort ; l'éjaculation rétrograde (à sec) est fréquente, et l'urgenterie/fuites initiales se résolvent généralement.
3. Le sondage est de courte durée. Consultez en cas d'impossibilité d'uriner, de saignement abondant ou de fièvre.